Клинические рекомендации

Аномалии и деформации зубочелюстной системы и лицевого черепа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**K07.0** — Основные аномалии размеров челюстей **K07.1** — Аномалии челюстно-черепных соотношений **K07.4** — Аномалия прикуса неуточненная **Q18** — Другие врожденные аномалии [пороки развития] лица и шеи
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 29.12.2023, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/779_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Термины 3

2.2 Причины 4

2.3 Классификация 4

3. Диагностика 4

3.1 Жалобы и анамнез 4

3.2 Осмотр и антропометрия 5

3.3 Лабораторные исследования перед операцией 5

3.4 КТ лицевого черепа 5

3.5 МРТ височно-нижнечелюстного сустава 5

3.6 Консультации специалистов 5

4. Лечение 5

4.1 Общие принципы 5

4.2 III класс: избыточный рост нижней челюсти 6

4.3 III класс: недоразвитие верхней челюсти 6

4.4 III класс: избыток нижней и недоразвитие верхней челюсти 6

4.5 II класс: избыток верхней и недоразвитие нижней челюсти 6

4.6 II класс: недоразвитие нижней челюсти 6

4.7 Сужение верхней челюсти, перекрёстная окклюзия 6

4.8 Вертикальная резцовая дизокклюзия 7

4.9 Асимметричные аномалии 7
4.10 Иное лечение 7
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 7
5.1 Показания к госпитализации 7
5.2 Реабилитация 7
5.3 Профилактика и диспансерное наблюдение 7
6. Источник и актуальность 8
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 8

1. Основные положения

- Зубочелюстная аномалия (деформация) — диспропорция развития челюстей с функциональными и эстетическими нарушениями; может затрагивать челюсти, скуловые кости, структуры носа и другие кости лицевого черепа.
- Всем пациентам — консультация оториноларинголога. При нарушении носового дыхания — оценка ЛОР-органов и функции внешнего дыхания (передняя активная риноманометрия, акустическая ринометрия), по показаниям — хирургическая коррекция внутренних структур носа.
- Обязательны КТ лицевого черепа (КЛКТ или МСКТ) и МРТ височно-нижнечелюстного сустава.
- Скелетные аномалии лечат хирургически (ортогнатические операции) вместе с ортодонтом: подготовка до операции и коррекция после.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Термины

Термины

Термин	Определение
Аномалия	врождённое отклонение от нормы или общей закономерности
Деформация	изменение размеров, формы и конфигурации кости от внешних или внутренних факторов
Окклюзия	вид смыкания зубных рядов
Прикус	соотношение челюстей в положении центральной окклюзии
Дистальная окклюзия	нижний зубной ряд смещён назад относительно верхнего, резцовая дизокклюзия, нарушение соотношения боковых зубов в сагиттальном направлении
Мезиальная окклюзия	нижняя челюсть смещена вперёд относительно верхней
Вертикальная резцовая дизокклюзия	нет окклюзионных контактов между резцами
Ортогнатическая хирургия	нормализация формы, размеров, положения и соотношения челюстей; включает и приёмы для профилактики нарушения носового дыхания
Гениопластика	остеотомия подбородочного отдела нижней челюсти для изменения контуров подбородка, по эстетическим показаниям

2.2 Причины

Возникают при

1. наследственной предрасположенности и генетических заболеваниях;
2. врождённых аномалиях челюстно-лицевой области: расщелины губы, альвеолярного отростка и нёба, гемифациальная микросомия, синдромы Робена и Гольденхара;
3. нарушениях развития височно-нижнечелюстных суставов;
4. травмах челюстей с поражением зон роста;
5. рахите, нарушениях обмена кальция, эндокринопатиях.

Менее значимые причины

1. нарушение носового дыхания;
2. макроглоссия;
3. неправильное грудное вскармливание;
4. осложнения кариеса, недостаточная жевательная нагрузка.

2.3 Классификация

Рабочая классификация скелетных зубочелюстных аномалий

1. **по типу окклюзии**: по сагиттали — дистальная или мезиальная окклюзия; по трансверсали — перекрёстная окклюзия; по вертикали во фронтальном участке — вертикальная резцовая дизокклюзия;
2. **по межчелюстному соотношению**: II скелетный класс (дистальный прикус), III скелетный класс (мезиальный прикус), сужение челюсти (перекрёстная окклюзия);
3. **по симметричности**: симметричная, асимметричная.

У взрослых клиническая картина сложнее, чем у детей: к аномалии присоединяются потеря зубов, деформация зубных рядов и челюстей, функциональная перегрузка пародонта, нарушения окклюзии.

---

3. Диагностика

Диагноз — по анамнезу, клинической оценке, моделям зубных рядов, антропометрическому анализу и лучевым исследованиям: ОПТГ, ТРГ, КЛКТ или МСКТ, МРТ.

Обследование включает

1. анамнез;
2. местный и стоматологический статус;
3. рентгенологическое обследование;
4. соматический статус;
5. психоневрологический статус при нелабильной психике;
6. состояние ЛОР-органов при нарушении дыхания: функция внешнего дыхания, передняя активная риноманометрия, акустическая ринометрия.

3.1 Жалобы и анамнез

Выяснить жалобы на

1. изменение конфигурации челюстей или лица, асимметрию челюстей и лица;
2. частичную потерю зубов;
3. затруднение движений нижней челюсти и жевания;
4. хруст, щелчки, боль в височно-нижнечелюстных суставах;
5. нарушение носового дыхания;
6. реже — дефект речи.

3.2 Осмотр и антропометрия

Начать с оценки симметрии лицевого скелета и черепа, определения прикуса и антропометрических измерений лица.

Видимая деформация, асимметрия лица, нарушение окклюзии и межчелюстных соотношений — первичное звено обследования. Антропометрия объективно оценивает выраженность аномалии, гипсовые модели зубных рядов — прикус.

3.3 Лабораторные исследования перед операцией

При подготовке к операции — лабораторные исследования, чтобы исключить сопутствующие заболевания.

3.4 КТ лицевого черепа

Всем — КТ лицевого отдела черепа (КЛКТ или МСКТ), с трёхмерной реконструкцией или без неё; шаг или толщина среза **не более 0,5 мм**. Без КЛКТ или МСКТ диагностика невозможна.

3.5 МРТ височно-нижнечелюстного сустава

Всем — МРТ височно-нижнечелюстного сустава: целостность и положение суставного диска.

3.6 Консультации специалистов

Оториноларинголог — всем: оценивает состояние ЛОР-органов и предупреждает осложнения с их стороны.

Ортодонт — всем: хирургическое лечение всегда сопровождается ортодонтической подготовкой и коррекцией после операции.

Генетик — всем: выявить синдром или нарушение костного метаболизма.

Анестезиолог-реаниматолог — перед операцией: операции травматичны, возможна значительная кровопотеря и гемотрансфузия.

Стоматолог-терапевт — перед операцией: подготовка зубов.

Стоматолог-ортопед — всем: дефекты зубных рядов, окклюзионные соотношения.

---

4. Лечение

Рекомендованный метод лечения скелетных зубочелюстных аномалий — хирургический.

Противопоказание — тяжёлые заболевания в стадии декомпенсации; после их лечения операция возможна.

Пациентам **младше 18 лет** операцию согласуют с ортодонтом, с учётом окончания роста — для профилактики рецидива.

4.1 Общие принципы

Единого метода нет: объём операции планируют индивидуально по типу и выраженности аномалии, этнической принадлежности и возрасту. Цель — устранить аномалию и создать условия для нормальной работы зубочелюстной системы; оценивают весь лицевой скелет.

Перед операцией — планирование объёма и методик вмешательства.

Перед операцией — специализированные программы для расчёта перемещения челюстей и изменения мягких тканей лица.

Во время ортогнатической операции — жёсткая фиксация титановыми пластинами и винтами: стабильный результат, меньше рецидивов.

Ортодонтическая подготовка до операции и коррекция после.

В некоторых случаях — метод «surgery first», без предоперационной ортодонтической подготовки.

4.2 III класс: избыточный рост нижней челюсти

Двусторонняя межкортикальная скользящая остеотомия нижней челюсти (BSSO) — уменьшить её размеры.

Большой подбородочный отдел — редукционная гениопластика по эстетическим показаниям.

4.3 III класс: недоразвитие верхней челюсти

Остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I, возможна сегментарная.

Большой подбородочный отдел — редукционная гениопластика по эстетическим показаниям.

4.4 III класс: избыток нижней и недоразвитие верхней челюсти

Операции

1. остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I, возможна сегментарная, — увеличить верхнюю челюсть;
2. двусторонняя межкортикальная скользящая остеотомия нижней челюсти (BSSO) — уменьшить нижнюю;
3. при большом подбородочном отделе — редукционная гениопластика по эстетическим показаниям.

4.5 II класс: избыток верхней и недоразвитие нижней челюсти

Операции

1. остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I, возможна сегментарная, — уменьшить верхнюю челюсть;
2. двусторонняя межкортикальная скользящая остеотомия нижней челюсти (BSSO) — увеличить нижнюю;
3. остеотомия подбородочного отдела — по эстетическим показаниям.

Выраженная «десневая улыбка» — ротация верхней челюсти против часовой стрелки.

4.6 II класс: недоразвитие нижней челюсти

Двусторонняя межкортикальная скользящая остеотомия нижней челюсти (BSSO) — увеличить её размеры.

Остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I.

Малый подбородочный отдел — увеличивающая гениопластика по эстетическим показаниям.

4.7 Сужение верхней челюсти, перекрёстная окклюзия

Тактика

1. оценить возраст и степень сращения нёбного шва;
2. вместе с ортодонтом решить, возможно ли ортодонтическое расширение;
3. при сращённом шве или невозможности расширения — остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I и по срединному нёбному шву с дистракционным аппаратом; величину расширения определяет ортодонт.

4.8 Вертикальная резцовая дизокклюзия

Операции

1. сегментарная остеотомия верхней челюсти с ротацией фронтального фрагмента из 4 или 6 зубов — профилактика рецидива;
2. ортодонтическая подготовка: промежутки (тремы) между зубами в местах остеотомии, чтобы не повредить корни;
3. остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I, BSSO, остеотомия подбородочного отдела.

4.9 Асимметричные аномалии

Тактика

1. по КЛКТ или МСКТ в специализированной программе оценить возможную послеоперационную деформацию;
2. остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I, BSSO, остеотомия подбородочного отдела по эстетическим показаниям; при симметричном положении одной из челюстей — одночелюстная операция.

Остаточная асимметрия после перемещения челюстей — краевая резекция или аугментация.

4.10 Иное лечение

Нарушение носового дыхания — по показаниям хирургическая коррекция внутренних структур носа.

Патология височно-нижнечелюстного сустава — артроцентез, артролаваж, диагностическая артроскопия.

Оценить показания к липосакции, липофилингу, платизмопластике, ботулинотерапии и другим методам пластической хирургии — для улучшения эстетики.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Ортогнатические операции — в круглосуточном стационаре, планово, челюстно-лицевыми хирургами.

Плановая госпитализация

1. нужна ортогнатическая операция или ортодонтическая коррекция амбулаторно невозможна;
2. диагностические или лечебные манипуляции нельзя выполнить амбулаторно.

Выписка

1. нет показаний к дальнейшему лечению в стационаре;
2. перевод в другое учреждение;
3. требование пациента или законного представителя;
4. нарушение предписаний, если это не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих.

5.2 Реабилитация

После операции — реабилитация до полного социального и физического восстановления.

Команда: челюстно-лицевой хирург, ортодонт, анестезиолог-реаниматолог; при необходимости — невролог, офтальмолог, оториноларинголог, генетик, логопед. Специфической реабилитации нет.

5.3 Профилактика и диспансерное наблюдение

При симптомах аномалии костей черепа и лица — консультация челюстно-лицевого хирурга. Специфической профилактики нет: рациональное ведение беременности, при выявлении — обследование у ортодонта.

После операции — осмотры челюстно-лицевого хирурга и ортодонта **не реже раза в 6 месяцев**.

Подозрение на рецидив, вторичную деформацию, ухудшение местного, неврологического или офтальмологического статуса — КТ черепа, МРТ головного мозга, ЭЭГ и другие исследования по клинической картине.

На исход влияют отрицательно

1. инфекционные осложнения;
2. несоблюдение местной контактной криотерапии;
3. плохая гигиена полости рта;
4. нарушение диеты и ограничения жевания;
5. несоблюдение ношения межчелюстной эластической тяги;
6. несоблюдение лечебной физкультуры;
7. пропуск контрольных осмотров и других рекомендаций врача.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Врожденные и приобретенные аномалии и деформации зубочелюстной системы и лицевого черепа»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 29.12.2023
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2026 года
Код в рубрикаторе	779_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Рекомендации для взрослых, но в разделе 3 есть указание об операциях у пациентов младше 18 лет — с согласованием с ортодонтом.
- Текст PDF — скан с ошибками распознавания (Le Fort I, BSSO); цитаты журнала сверки приведены по распознанному тексту.